## 内科 + 外科 急性胰腺炎 ★★★（1~4 题）

### 去除病因 控制炎症 抑制胰液 维持肠道 防治感染

即使重症胰腺炎应尽可能内科及微创治疗

- 最基本：禁食补液、胃肠减压
  （内 2010、2012、2015、2022，外 2014、2016、2018、2021）
- 生长抑素 / 奥曲肽、加贝酯（抑制胰酶活性）、奥美拉唑或西咪替丁
  肠功能恢复后尽早肠内营养：鼻 - 空肠管、空肠造瘘
  谷氨酰胺（保护肠粘膜屏障）
- 胰腺坏死＞ 30% 可预防性静注碳青霉烯类（培南）
  降阶梯：碳青霉烯类、三代头孢 / 喹诺酮类 + 甲硝唑
  坏死组织清除和外引流术（外 2008、2017、2025）

### 对比

- 高脂血症与急性胰腺炎互为因果
- 高钙血症是急性胰腺炎病因之一，低钙血症是急性胰腺炎结果之一
- ERCP 可致急性胰腺炎（外 2010、2012）
  胆总管下端结石嵌顿致梗阻（胆总管扩张＞ 1cm）或胆道感染尽早 EST+ 取石 +ENBD（外 2017、2025）
- 诊断胰腺炎的影像检查：CT 最佳、B 超首选（外 2014）
- 《内科》：禁用吗啡（内 2012，外 2023）、阿托品
  《外科》：可用阿托品
- 急性胰腺炎抑制胰酶，慢性胰腺炎补充胰酶（得每通）